

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5030589-84.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL MARCELO DA ROCHA ROSADO

RECORRENTE: TATIANE MARIA DA HORA

ADVOGADO(A): EDUARDO JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (DPU)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VIANA

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Com o trânsito em julgado baixem os autos e arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 16 de dezembro de 2024.

5030589-84.2024.4.02.5001

500003483270 .V2

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5030589-84.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL MARCELO DA ROCHA ROSADO

RECORRENTE: TATIANE MARIA DA HORA

ADVOGADO(A): EDUARDO JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (DPU)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO E OUTROS

RELATÓRIO

1. TATIANE MARIA DA HORA interpõe recurso em razão de decisão interlocutória proferida pelo Juiz do juizado adjunto à 4ª Vara Federal Cível, que indeferiu seu pedido de tutela de urgência antecipada com o fim de obter a realização do exame de cápsula endoscópica. Argumenta, em síntese, que é portadora de anemia ferropriva severa (anemia por deficiência de ferro) há mais de 10 anos, refratária ao tratamento com 'Fe'. Ainda, que em 2022 foi detectada perda sanguínea pelo trato gastrointestinal; porém, as endoscopias digestivas altas e as colonoscopias foram insuficientes, demonstrando assim que o sangramento é proveniente do intestino delgado, não alcançado por outros exames convencionais, o que demonstra a necessidade do exame requerido. Afirma que o exame foi solicitado desde 2022; contudo, a autora não conta com condições financeiras de realizá-lo. Assevera que o laudo pericial foi favorável ao pedido do exame, bem como NOTA TÉCNICA SESA/GAB/GEDEJ nº 1103/2024 juntada aos autos pelo Estado de Espírito Santo, que informou que a solicitação do exame, datada de 21/02/2024, já se encontrava autorizada. Afirma que resta atendido o requisito do artigo 300 do CPC – probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano, esse advém das consequências deletérias da omissão estatal, tendo em vista que, quanto mais tempo passar sem diagnóstico correto e tratamento adequado, mais comprometida fica a saúde da requerente.

2. Decisão monocrática indeferindo o pedido de tutela de urgência (evento 3).

3. A parte contrária apresentou contrarrazões (eventos 9 e 10)

4. É o relatório. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso e passo ao exame do seu mérito.

VOTO

5. Quanto ao mérito, entendo que as condições fáticas e jurídicas que justificaram a decisão proferida no evento 3 permanecem as mesmas, de modo que me valho das razões expendidas como razões de decidir o mérito do presente agravo. Eis os termos lançados:

03. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso e passo ao exame do seu mérito.

04. Nos termos do artigo 300 do CPC, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo”. O juízo processante considerou, em sua decisão que:

Decisão de evento n. 19 indeferiu a tutela provisória de urgência por não se verificar, ainda em cognição sumária, a existência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Determinada a realização da perícia médica (evento n. 48), houve a juntada de laudo pericial no evento n. 80.

Seguidamente, a parte autora reiterou o pedido de tutela de urgência (evento n. 89) e informou que, apesar de o serviço de saúde constar como autorizado no sistema de regulação, ainda não foi cumprido administrativamente pelo Estado do Espírito Santo (evento n. 96).

Pois bem.

Em que pesem as alegações autorais, verifico que subsiste a ausência do pressuposto da urgência necessário à concessão da tutela provisória requerida, na forma do art. 300, do CPC.

Com efeito, o próprio laudo pericial de evento n. 80 consignou que não há risco imediato no quadro clínico da autora apto à caracterização de urgência/emergência (Enunciado n. 51, da Jornada de Saúde do CNJ).

Mantenho, portanto, o indeferimento da tutela provisória de urgência.

05. Em que pese o quanto argumentado, o laudo do Evento 80 (feito de origem) afirma categoricamente, em resposta aos quesitos 1 e 2 da União, que não existe risco imediato à autora, não restando caracterizada a urgência/emergência da medida pleiteada. Nem mesmo a documentação médica colacionada pela autora (também no feito de origem) afirma a urgência na realização do exame, mas tão-somente a necessidade de sua realização, como se vê, por exemplo, no Evento 1 - ANEXO2 - fl. 15, documento repetido no Evento 54 - ANEXO2.

06. A informação trazida pela recorrente de que nos autos do feito de origem o Estado do Espírito Santo afirmou, em 20/06/2024, que a solitação do exame, datada de 21/02/2024, já estaria autorizada, "sendo a próxima etapa a marcação, dependendo da disponibilidade dos prestadores", não caracteriza a urgência autorizadora da concessão da tutela de urgência. De outro lado, a mora administrativa não é causa de pedir no feito de origem, de modo que não cabe nessa seara perquirir a respeito.

07. De todo modo, não se afigura, por momento, elementos suficientes à concessão da tutela de urgência pretendida.

08. Assim sendo, indefiro o pedido de tutela de urgência, mantendo hígida a decisão ora recorrida.

09. Intimem-se as partes do ora decidido, bem como o Estado do Espírito Santo para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo legal. Após as providências, retornem os autos a essa Relatoria.

6. Embora o direito à saúde seja constitucionalmente garantido a todos, cabendo ao Estado, em sentido lato, promovê-lo mediante políticas sociais e econômicas (arts. 6º e 196 da CRFB/88), não se pode prejudicar outras pessoas em igual ou até pior situação, que têm prioridade na fila organizada administrativamente, sob pena de afronta ao princípio da isonomia.

7. Assim sendo **VOTO POR CONHECER e NEGAR PROVIMENTO** ao recurso. Com o trânsito em julgado baixem os autos e arquivem-se.